

31. MEP TRACTUS GASTRO-INTESTINAL 1 : DÉLIMITATION DE L' EMBRYON

DURÉE : 05:35

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde en profondeur la mise en place du tractus gastro-intestinal ainsi que la délimitation de l'embryon, en se concentrant sur le développement de l'estomac, du duodénum et du côlon. Les concepts clés tels que la synchronicité du développement, la dynamique des mouvements tridimensionnels, et l'importance du diaphragme pour la délimitation sont explorés. Les relations entre les différents organes, le péritoine et les structures associées sont détaillées, incluant des éléments comme le mésogastre et les épiplombs. Ce contenu offre des bases solides pour toute pratique thérapeutique, en soulignant l'importance d'une compréhension intégrale des processus embryologiques dans l'ostéopathie.

MISE EN PLACE DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET DÉLIMITATION DE L' EMBRYON

Nous allons étudier la **mise en place** du **tractus gastro-intestinal**, de la **cavité péritonéale** et du **péritoine** dans le développement de l'estomac, du duodénum, de l'intestin et du côlon.

Commençons par comprendre le développement de l'estomac en relation avec le **foie**, la **rate** et le **pancréas**. Il est essentiel de saisir la phase initiale, que l'on appelle la **délimitation de l'embryon**. Nous avons observé l'intégration du **cellome externe** en un **cellome interne**. À ce stade, nous pouvons voir l'intégration de la cavité péritonéale, tant dans le plan sagittal que transversal.

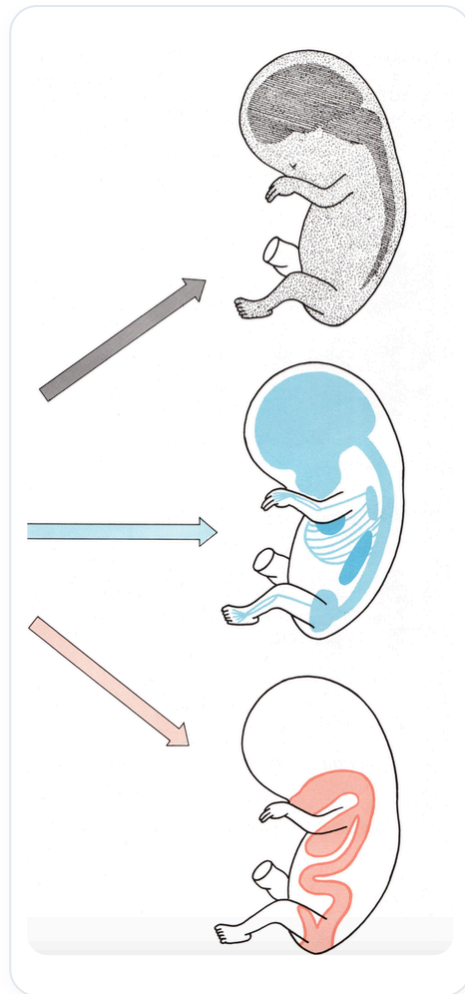


FIG. — Feuilles embryonnaires

N'oubliez pas la **synchronicité** du développement. La croissance est le grand moteur de ce processus, avec la formation de notre corps dans un ordre primitif.

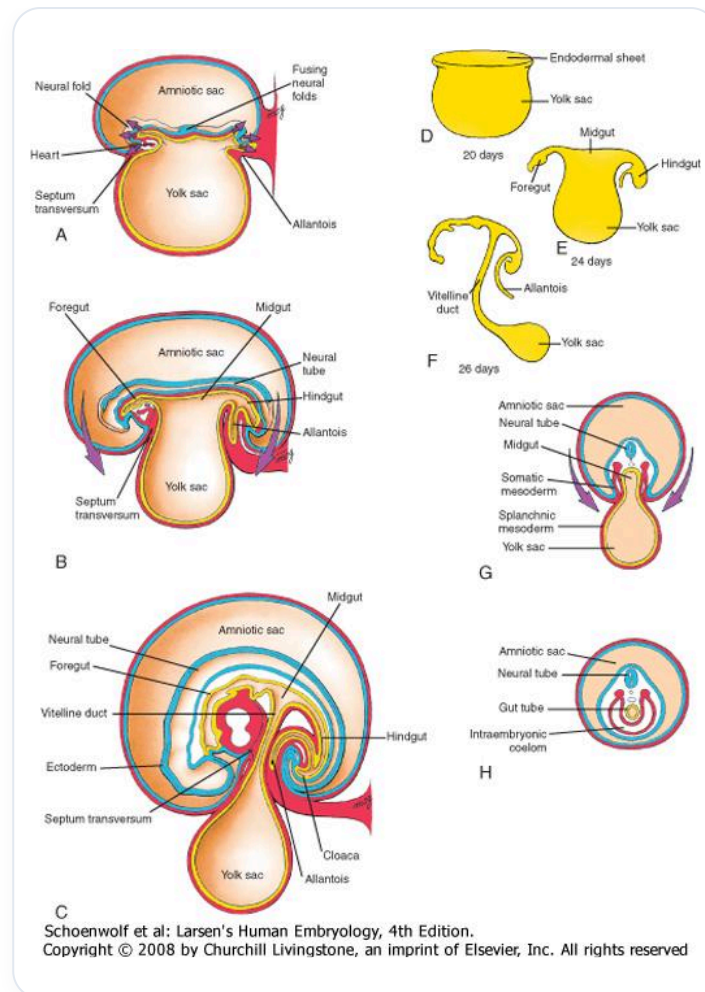


FIG. — Pliage embryonnaire latéral

La croissance globale de l'embryon, son enroulement et son retour vers la ligne médiane sont des mouvements tridimensionnels, et même à la **cinquième dimension**. La quatrième dimension représente le temps, tandis que la cinquième dimension fait référence à la composante **énergétique** et **électrique** qui sous-tend tout le système.

Ce mouvement est toujours intégré dans la phase d'**ascension de l'ectoderme** et de **descente relative de l'endoderme**, avec une phase presque au niveau du cœur. L'ascension de l'ectoderme et la descente de l'endoderme, ainsi que l'intégration du cœur, étirent les **bauges** de la musculature diaphragmatique et des futurs muscles antérieurs du cou. Pour traiter et réorganiser cet espace, il est crucial de comprendre qu'il faut traiter et libérer le **diaphragme**, car c'est lui qui crée cette délimitation globale.

L'ascension du **tube neural**, le développement de la cavité péritonéale et la mise en place du cœur forment un mouvement qui se réintègre globalement vers un point d'appui appelé le **cordon ombilical**. Ce cordon contient l'histoire de ce développement, de cette délimitation et de cette réorganisation du péritoine.

Ce processus s'intègre dans des mouvements de **rotation spécifiques**, organisés dans des sens horaires et anti-horaires. Sur un plan frontal, nous observons un mouvement de développement global **anti-horaire**, tandis que sur un plan transversal, le mouvement est **horaire**. La cavité

péritonéale commence à s'organiser et à se délimiter, ce qui implique qu'elle va bouger.

Le péritoine entoure un organe, ce qui est appelé un **péritoine viscéral**. Lorsqu'un péritoine relie un organe à la partie postérieure, cela s'appelle un **méso**. Par exemple, pour l'estomac, cela s'appelle un **mésogastre**, pour le duodénum, un **mésodiédénum**, et pour le côlon, un **mésocolon**. En fonction de la localisation, cela peut également être désigné comme un **fascia de Tholt**. Pour l'intestin grêle, on parle d'un **mésentère**.

Le péritoine à la partie postérieure est appelé **péritoine pariétal postérieur**, tandis qu'à la partie latérale, il est désigné comme **péritoine pariétal antérieur**. Si un péritoine relie un organe à un autre organe, cela s'appelle un **épiplomb**. Par exemple, le petit épiplomb relie le foie à l'estomac, et il existe également un épiplomb reliant la rate à l'estomac.

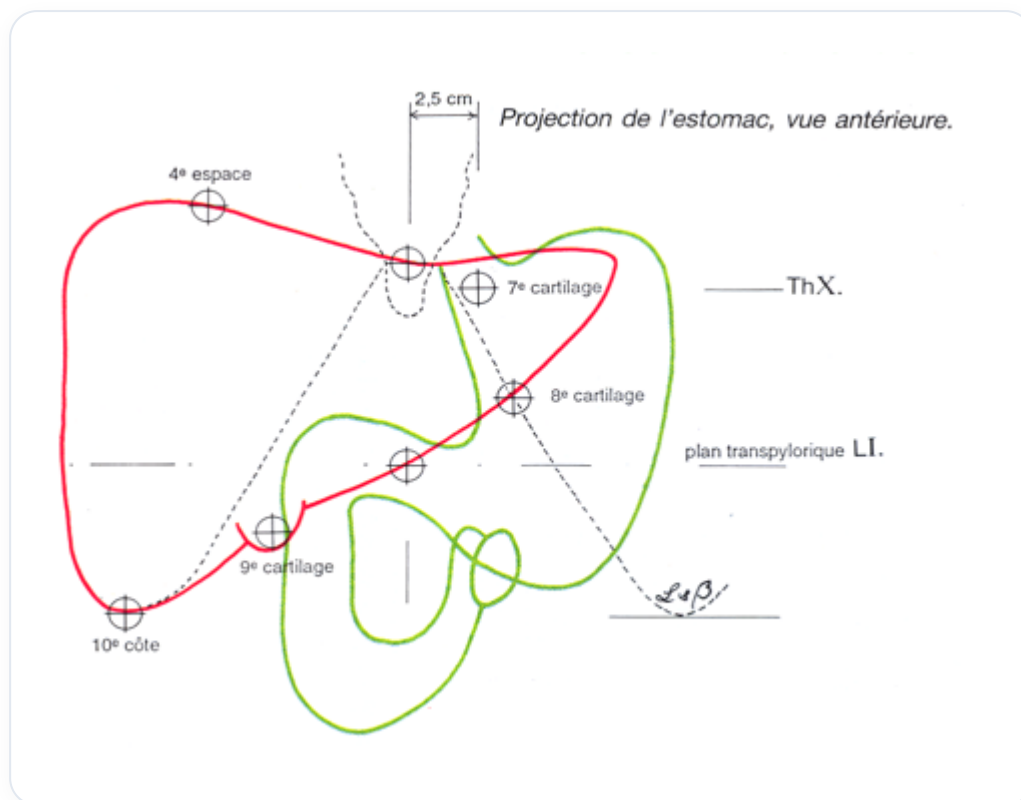


FIG. — Projection estomac antérieure

Un épiplomb ou un méso est toujours une double lame qui contient un vaisseau au milieu. Dans le mouvement développemental, des replis et une réorganisation se produisent, permettant à l'épiplomb, par exemple le méso, de se déplacer sur le côté. Cela forme un **fascia d'accolement**, qui peut être réséqué par les chirurgiens sans problème, car il n'y a pas de vaisseau. Un méso, en revanche, contient toujours un vaisseau, tandis qu'un ligament ou un fascia ne contient pas nécessairement de vaisseau.

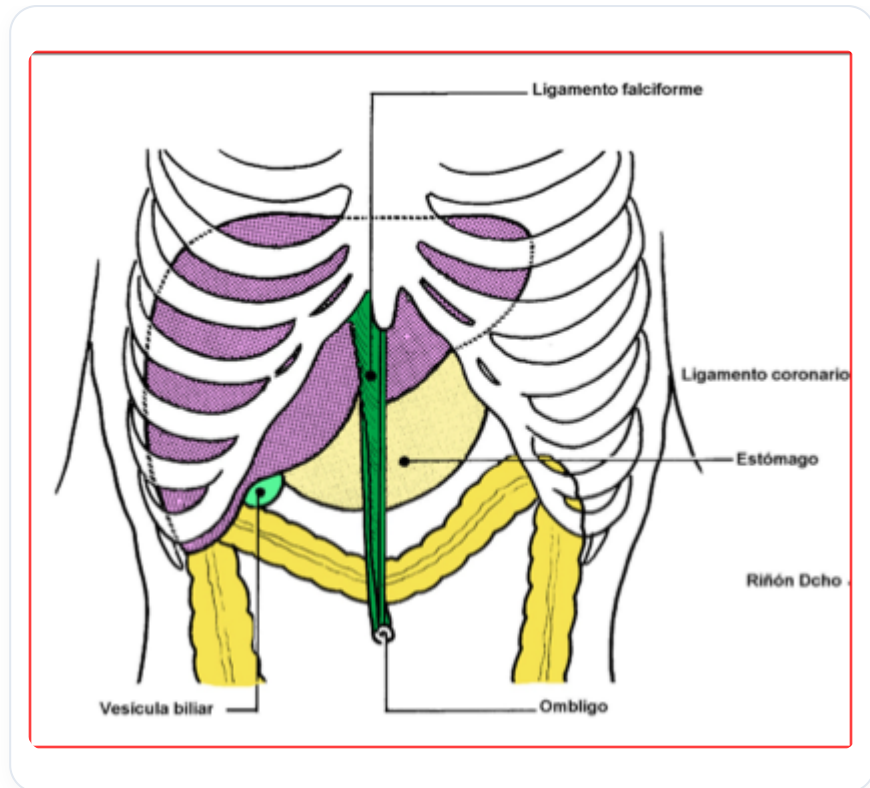


FIG. — Anatomie abdominale supérieure

Au niveau du péritoine, nous avons le **mésoderme**, la **somatopleure**, la **splanchnopleure**, ainsi que le **mésogastrome** ventral et dorsal. Nous avons également des méso, des fascia, des **omentums** (épiplombs) et des ligaments. Tout cela constitue le péritoine, organisé dans la cavité péritonéale.

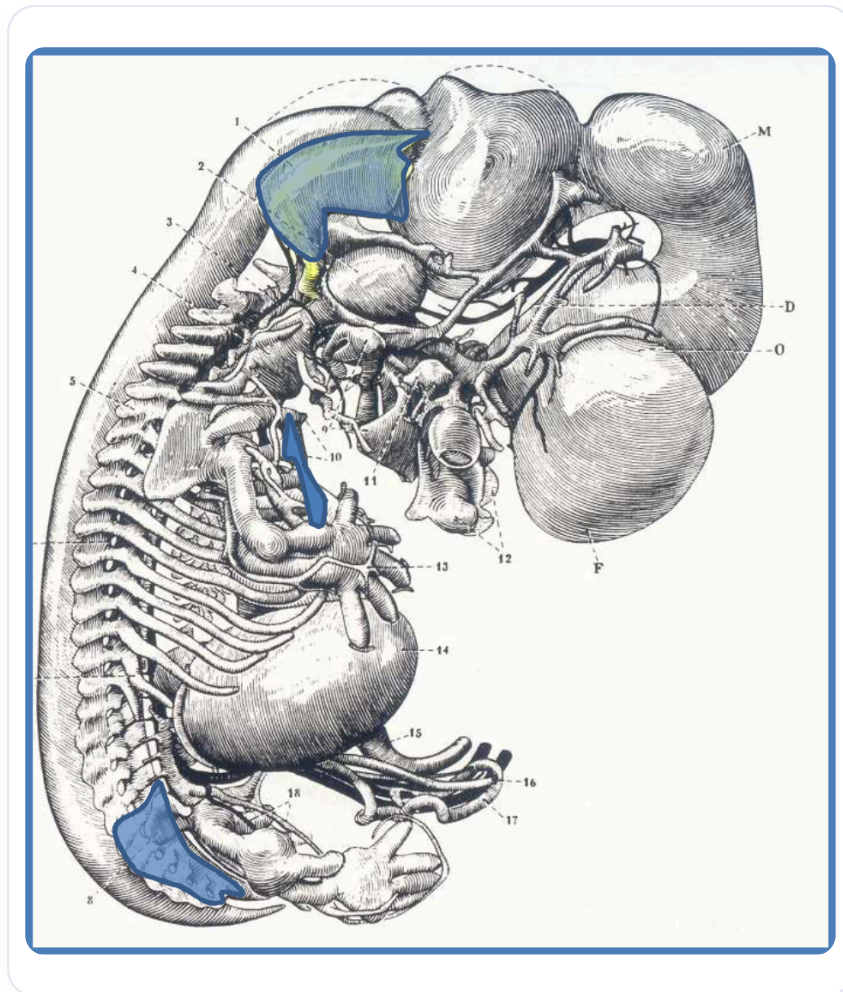
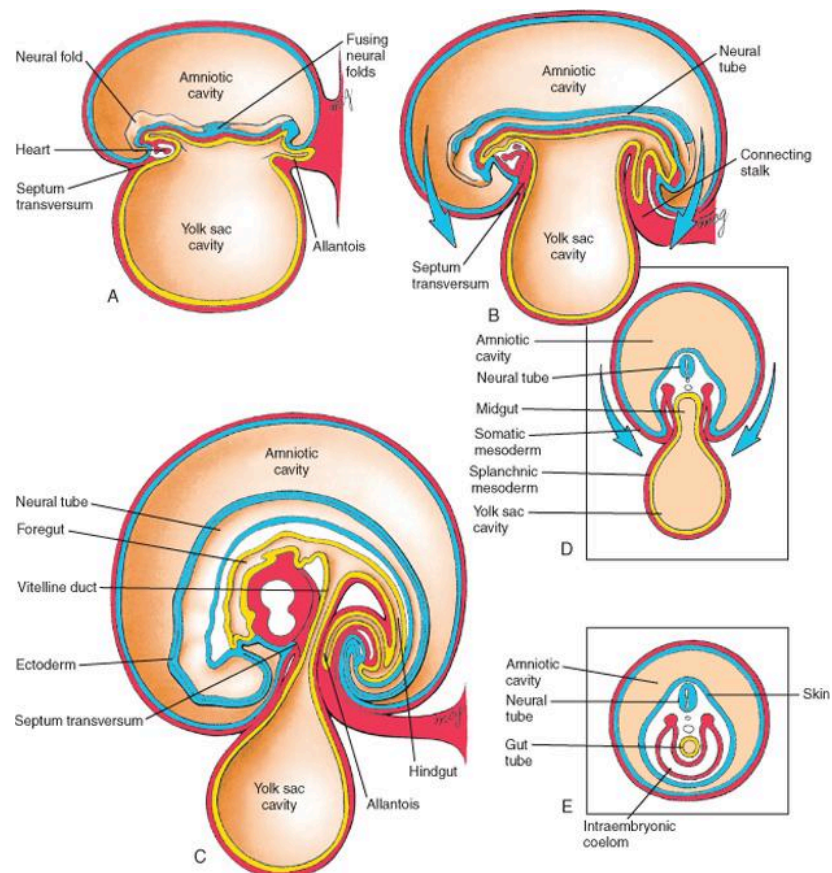


FIG. — *Embryon humain, organes*

L'intestin commence à grandir, le foie se développe, l'estomac veut s'exprimer et les poumons poussent. Tout cela doit trouver sa place.



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — *Pliage embryonnaire latéral/crânio-caudal*

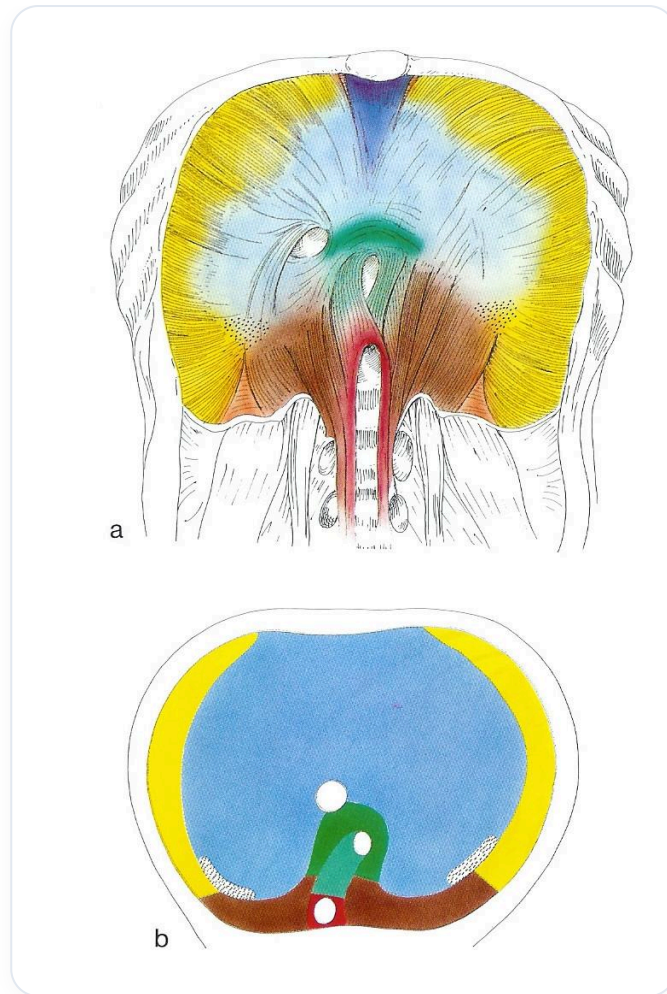


FIG. — *Diaphragme humain*

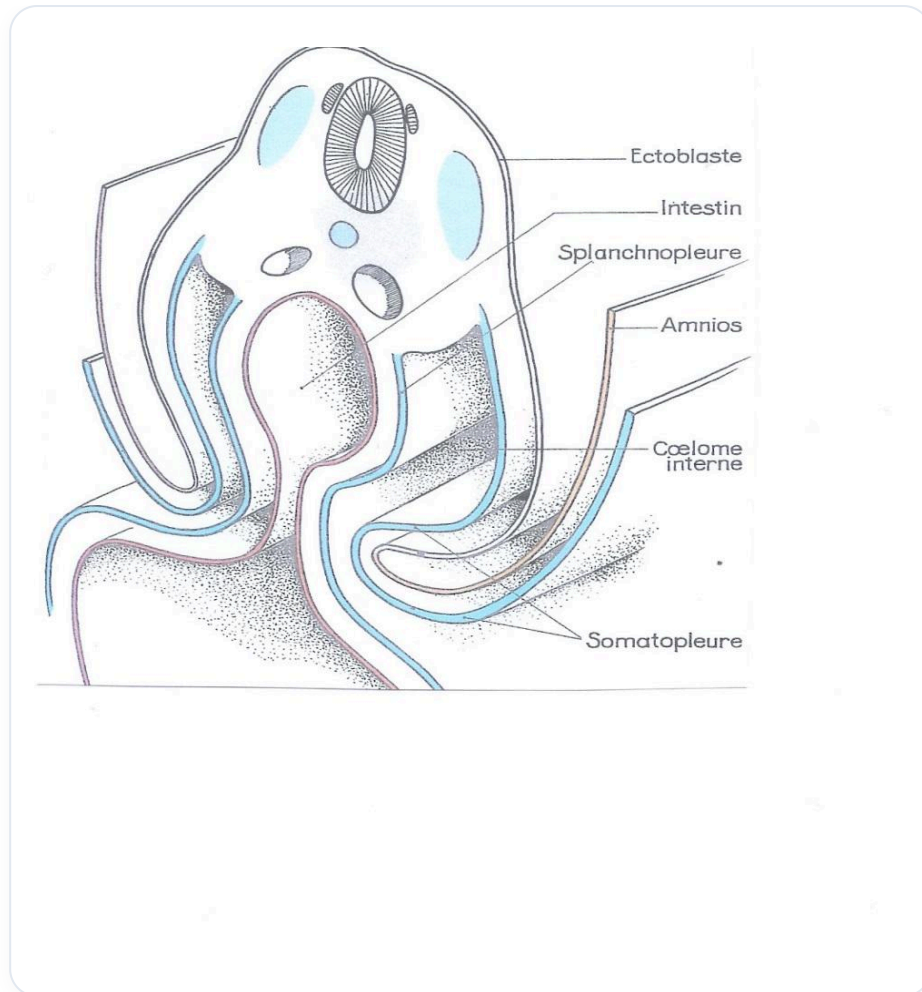


FIG. — *Pliement embryonnaire latéral*